PROTOCOLLO 68

# Apertura progressiva con abbassalingua

Aumentare gradualmente il range con un metodo misurabile

| FASE | QUADRO CLINICO | DURATA | FREQUENZA |
|---|---|---|---|
| Subacuta e cronica | Ipomobilità | 5 a 10 minuti | Ogni giorno a domicilio |

## Indicazioni

- ✓ Ipomobilità
- ✓ Trisma in fase di recupero
- ✓ Necessità di un obiettivo misurabile

## Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

## Posizionamento

**Paziente:** seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

**Fisioterapista:** di fronte al paziente per insegnare e correggere.

## Esecuzione passo dopo passo




**Misura iniziale**

Conta quanti abbassalingua sovrapposti entrano tra gli incisivi senza dolore.




**Mantenimento**

Mantieni l'apertura per il tempo indicato.




**Progressione**

Aggiungi un abbassalingua quando è facile.




**Registrazione**

Annota il numero ogni giorno.

## Dosaggio

| PARAMETRO | INDICAZIONE |
|---|---|
| **Tenuta** | da 30 secondi a 5 minuti |
| **Frequenza** | 3 volte al giorno |
| **Progressione** | +1 abbassalingua quando tollerato |

## Criteri di rivalutazione

| APERTURA MASSIMA | DOLORE (NRS 0 A 10) | TRAIETTORIA |
|---|---|---|
| ____ mm | ____ / 10 | Retta / Deviata |
| senza dolore e massima, con calibro | a riposo e in funzione | osservata allo specchio |

### Punti chiave

- ✓ Metodo semplice e motivante
- ✓ Progressione lenta
- ✓ Registra i progressi

### Errori da evitare

- ! Aggiungere troppi abbassalingua
- ! Tenere con dolore
- ! Saltare le registrazioni

## Esercizio domiciliare associato

| ESERCIZIO | ESECUZIONE | DOSAGGIO |
|---|---|---|
| **Pila di abbassalingua** | Mantenere l'apertura con il numero raggiunto | 3 volte al giorno |

! **Nota clinica.** La misura con gli abbassalingua offre al paziente un feedback concreto dei progressi.

## Bibliografia essenziale


1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.